

如 廁 訓 練 大 寶 典



長輩一直跑廁所， 怎麼辦？

失智・衰弱・失禁長輩的如廁照顧 QA 手冊

9 大情境 QA

國際實證依據

影片教學

圖解示範

施昱廷 職能治療師 | 整理編寫

照顧長輩的你，辛苦了。

「一直吵著要上廁所」「來不及走到廁所就濕了」「怕他尿床，不敢讓他喝水」——這些狀況，幾乎是每個照顧失智或衰弱長輩的家庭都會遇到的日常。

這本小手冊想告訴你兩件事：**第一，這些問題大多找得到原因；第二，找到原因，就有方法。**以下 9 個情境都以問答方式呈現，每一題先給你一句話的答案，再告訴你具體怎麼做。方法都有國際研究依據，出處放在各段落與手冊最後；部分主題也附上優質的影片教學，掃描連結就能跟著做。

你可以從頭讀，也可以直接從目錄挑你最頭痛的那一題。

目錄 | 你現在最困擾的是哪一個？

Q1 長輩一直說要上廁所，剛上完又要去，是失智變嚴重了嗎？

Q2 怕他一直尿，可以少給他喝水嗎？

Q3 常常來不及走到廁所就漏出來了，怎麼辦？

Q4 失智長輩找不到廁所、甚至拒絕進廁所，怎麼辦？

Q5 已經包尿布了，還有機會脫離尿布嗎？

Q6 半夜一直起來上廁所，全家都睡不好，怎麼辦？

Q7 長輩排便好困難，需要買腳凳嗎？

Q8 尿意一來就忍不住，有辦法「訓練」嗎？

Q9 什麼狀況應該趕快就醫？

Q1

長輩一直說要上廁所，剛上完又要去，是失智變嚴重了嗎？

情境：阿嬤十分鐘前才上完廁所，現在又吵著要去。家人開始不耐煩：「不是剛上過嗎！」

◆ 一句話答案：頻尿不等於膀胱壞掉，更不一定是失智惡化——先當偵探，找原因。



一直想尿

喝太少

感染

咖啡因

膀胱過動

便秘

藥物

血糖

習慣心理

8 種常見原因，大多可以處理 ↓ 對照下表

可能原因	觀察線索	第一步行動
喝太少水	尿色深、尿量少、一天喝不到 1,500 ml	逐步增加飲水（見 Q2）
泌尿道感染	突然變頻、尿急灼熱、尿混濁有異味；失智長輩常表現為「突然變得混亂躁動」	就醫驗尿
咖啡因與濃茶	頻尿集中在喝茶、咖啡後 1—2 小時	記錄飲品時間，改淡茶或上午喝
膀胱過動	突然強烈尿意、來不及到廁所	急尿煞車法（見 Q8）
便秘	3 天以上沒排便＋頻尿同時出現（糞便壓迫膀胱）	先處理便秘（見 Q7）
藥物影響	吃利尿劑、排糖藥後 2—4 小時明顯多尿	與醫師討論服藥時段
血糖過高	多尿＋一直口渴＋體重下降	驗血糖
習慣與心理	睡前大量喝水；或「怕來不及」的以防萬一心態	用 3 天如廁紀錄釐清（見 Q9 後附表）

給照顧者的提醒：失智長輩「突然」變得很頻尿或很混亂，第一個要排除的是泌尿道感染，不是「病情惡化」。很多家庭在這裡繞了遠路。

• • •

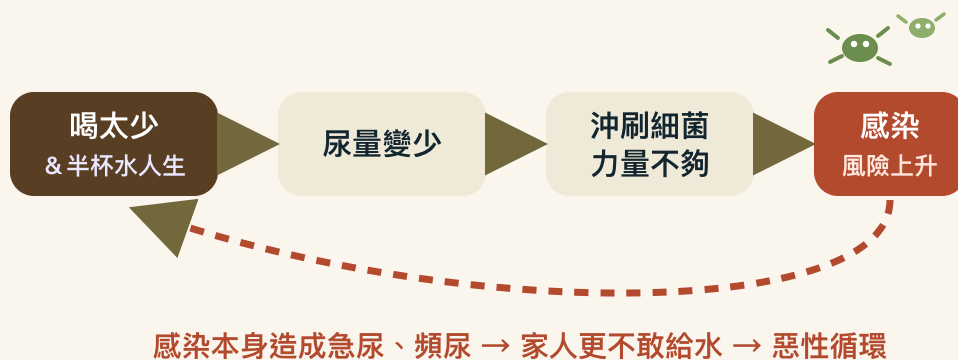
Q2

怕他一直尿，可以少給他喝水嗎？

情境：「他都會尿褲子，我想說水少喝一點，尿就少一點……」

◆ **一句話答案：**千萬不要。少喝水不會解決失禁，反而讓長輩更容易感染、更頻尿。

「少喝水」的惡性循環



換句話說：喝太少的問題，主要不是尿變濃刺激膀胱，而是尿量太少、沖刷不夠，泌尿道感染風險上升——而感染本身會造成急尿、頻尿。

研究怎麼說

- 一項發表於《JAMA Internal Medicine》的隨機對照試驗：原本每天喝不到 1.5 公升水的反覆膀胱炎女性，每天多喝 1.5 公升水之後，一年內膀胱炎發作次數少了將近一半（1.7 次 vs 3.2 次），抗生素使用也將近減半。
- 日本養護機構研究發現：整天包尿布的長輩，反而是喝水最少、吃得最少的一群——失禁的長輩更需要吃夠喝夠。

1 總量目標：白天平均分配，一天約 1,500 ml（有心衰竭、腎臟病、醫師限水者除外——請依醫囑）。

2 時間策略：水分集中在白天喝，睡前 2 小時減量——是「往前挪」，不是「減總量」。

3 搭配如廁方案：研究顯示單純調整喝水量效果有限，喝水一定要搭配 Q5 的定時引導如廁，效果才會出來。

實證來源：Hooton et al. (2018), JAMA Internal Medicine ; Kohno et al. (2023), The Journal of Medical Investigation ; Buck et al. (2024), Age and Ageing 。

常常來不及走到廁所就漏出來了，怎麼辦？

情境：阿公有感覺要尿，但從客廳走到廁所要一分多鐘，常常走到一半就濕了。

◆ 一句話答案：這叫「功能性失禁」——膀胱沒壞，是「到達廁所的過程」出了問題。這是最有機會改善的一種失禁。

機構研究顯示，功能性失禁是長輩失禁中最常見的類型（約占 45%）。改善方向有三條路，可以同時進行：



① 縮短「路程」

- 移除動線上的障礙物、加裝夜燈與扶手
- 房間離廁所太遠時，夜間在床邊放便盆椅（日間仍鼓勵走去廁所，維持活動量）

② 縮短「穿脫時間」

- 改穿鬆緊帶褲頭，避免皮帶、排扣
- 裙裝、寬鬆棉褲都是好選擇

③ 提前出發：改用「他的時間表」帶他去

- 記錄 3 天排尿時間，找出長輩自己的排尿規律（例如：早餐後 30 分鐘、午睡醒來）
- 在他慣性時間之前就主動帶去廁所——研究顯示這種「個人化時間表」比齊頭式的「每 2 小時帶一次」更有效，漏尿量可減少約四到五成



站不起來的長輩怎麼上廁所？如廁移位＋穿脫褲子全示範（13 分 10 秒）

YouTube・やしのき介護技術頻道（日本物理治療師示範，16 萬次觀看）

<https://www.youtube.com/watch?v=rk0A8H0PPj8>

看不懂日文沒關係——影片重點中文摘要

- 這部影片解決什麼？雙腳無力、站不太起來的長輩，要上馬桶／便盆椅時的「移位＋穿脫褲子尿布」——原本要兩個人的工作，教你一個人安全完成（最適合居家照顧與狹小廁所）。
- 核心手法「膝蓋支點」：協助者蹲低（或單膝跪地），一手掌心從上方壓穩長輩「靠馬桶那一側」的膝蓋當支點；讓長輩雙手環抱你的肩背，順勢帶他半站起——這時你的另一手就空出來，拉下（或拉上）褲子與尿布，再轉身慢慢坐上便座。
- 長輩的手擺哪裡很重要：要搭在你「肩膀與脖子之間」，不要壓在心窩（胸口正中央）——會痛，甚至可能引發嘔吐。
- 照顧者的護腰關鍵：雙腳打開、彎膝蓋與髖關節「蹲低」，不是彎腰；「掌心壓膝」這個支點沒做好，長輩的重量會全部壓到你的腰上。
- 不用一次到位：褲子沒拉好，讓長輩坐回去、再站一次就好；兩人身高體格差太多時不要硬做，找第二人協助或改用別的方法。
- 適用範圍提醒：此法適合「腳還有一點力氣」的長輩；完全無法出力或體重過重者，影片建議改在床上處理，安全第一。



包大人提拉密舒健康操（20 分鐘全身肌耐力操）——走得穩、站得起來，是自己上廁所的本錢

YouTube・Dr.P 包大人 | 帶長輩每天跟著做，記得保持呼吸、盡量伸展

<https://www.youtube.com/watch?v=M8OLl2xpWiM>

實證來源：Jerez-Roig et al. (2024), BMC Geriatrics（功能性失禁盛行率）；Colling et al. (2003)，引自 Buck et al. (2024), Age and Ageing（個人化排尿模式訓練）。

• • •

Q4

失智長輩找不到廁所、甚至拒絕進廁所，怎麼辦？

情境：阿嬤在家裡走來走去就是找不到廁所，最後尿在陽台；帶她進浴室她卻大力反抗。

◆ 一句話答案：先問「他為什麼做不到／不願意」，再對症處理——事出必有因。



- 大字＋圖案，貼在視線高度
- 門常開、燈常亮，讓馬桶被看見
- 夜間感應燈鋪一條「發光的路」

看得見，才想得起來

說不出「我要上廁所」→ 用圖卡代替語言

- 依失智程度選擇溝通方式：輕度用多選一圖卡、中度用二選一（大號／小便圖卡）、重度用是非題（拿一張圖卡問「要不要？」）
- 照顧者主動出示圖卡詢問，不要等長輩開口

拒絕、反抗 → 當偵探找原因

- 常見原因：怕水聲、鏡子裡的「陌生人」、浴室太冷、曾在廁所跌倒的恐懼、隱私被侵犯的感受
- 處理方向：蓋住鏡子、先開暖風再進去、改變協助的口氣與順序（「陪你去洗手」比「帶你去尿尿」容易被接受）
- 原則：把注意力放在處理原因，而不是壓制行為

照顧金句：他不是故意作對——是這個環境對他來說變得太難懂了。我們改環境，比要求他「配合」有效得多。

影片參考



專家來解泌 | 失智照護一把罩！讓長輩不「濕」尊嚴

YouTube · 泌尿專科衛教頻道

<https://www.youtube.com/watch?v=dECRAFXGvUY>

...

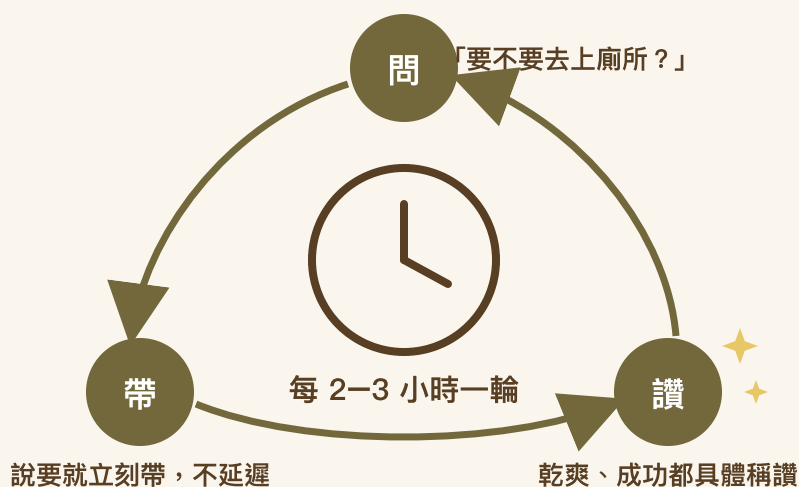
 已經包尿布了，還有機會脫離尿布嗎？

情境：出院後怕來不及，就直接包尿布了。半年過去，全家都以為「回不去了」。

◆ 一句話答案：很有機會。日本研究：實行「定時詢問+立即引導」11個月，尿布使用率從71%降到47%——而且完全不用限制喝水。

先看兩個會讓你意外的數字（日本調查）

- 包尿布的長輩中，約1/3其實只要有人協助，就能自己上廁所
- 約24%的尿布是「以防萬一」包的——不是真的需要



「讚」是最常被漏掉、卻最關鍵的一步——成功如廁與保持乾爽時，具體地稱讚他。

日本養護機構的「零尿布計畫」做法非常簡單，家裡也能做：

- 1 每2-3小時固定詢問一次：「要不要去上廁所？」——語氣像聊天，不是命令。
- 2 說「要」就立刻帶去，不延遲、不說「再等一下」。
- 3 說「不要」就尊重，下一輪再問；不會說話的長輩，觀察坐立不安、拉褲子等訊號。
- 4 排程以外的時間，只要表達尿意一律協助——時間表是主動出擊的底線，不是拒絕的理由。

5 走不到廁所 ≠ 包尿布：用輪椅、便盆椅協助移位，讓他保有「坐在馬桶上」的尊嚴。

6 全程正常吃、正常喝，並在成功如廁、保持乾爽時具體稱讚（「今天都乾乾的，真棒！」）。

務實的期待：研究顯示約 3—4 成長輩對這個方法反應特別好（失禁從一天近 4 次降到 1 次以下）。先試 2—4 週，觀察你家長輩是不是「高反應者」；就算不能完全脫離，從「整天包」退到「只有夜間包」，對皮膚、尊嚴、照顧負擔都是大進步。

影片參考



離床如廁篇：穿脫紙尿褲同時復健——適度讓長輩自己來

YouTube · 包大人長照小學堂（治療師示範）

<https://www.youtube.com/watch?v=1Y30XcoGgxs>



失禁一定要穿紙尿褲嗎？讓長輩自信又「敢動」的照護技巧

YouTube · udn 元氣網 × TENA（本手冊作者 施昱廷 職能治療師 參與講解）

https://www.youtube.com/watch?v=D_B1XCWqUmw

實證來源：Kohno et al. (2023), The Journal of Medical Investigation；Engberg et al. (2002) 與 Newman (2019) 之引導如廁（prompted voiding）實證。

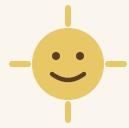
• • •

Q6

半夜一直起來上廁所，全家都睡不好，怎麼辦？

情境：阿公一個晚上起來 4 次，白天精神差，家人也被吵醒，還擔心他半夜跌倒。

◆ **一句話答案：**夜尿的處理原則是「水分往白天挪、藥物時間問醫師、動線做到防跌」。



早



上午



中午



下午



晚餐



睡前2hr

總量不變（約 1,500 ml），把水「往前挪」，不是「減量」

三管齊下

1. 水分往前挪：白天正常喝、睡前 2 小時開始減量；晚餐的湯與水果適量即可（見 Q2）。
2. 檢視藥物時間：利尿劑若在傍晚吃，夜尿一定多——請帶著藥單與醫師討論能否改到早上。
3. 夜間安全動線：感應夜燈、移除地毯與電線、必要時床邊放便盆椅。半夜跌倒的代價，遠大於一次床邊如廁的不便。

進階觀察

- 睡前雙腳水腫明顯的長輩：白天累積在下肢的水分，躺平後回流變成尿——傍晚可穿彈性襪或抬腿 30 分鐘，讓水分提早代謝。
- 夜尿伴隨打鼾與白天嗜睡：可能與睡眠呼吸中止有關，值得就醫評估。

• • •

Q7

長輩排便好困難，需要買腳凳嗎？

情境：網路上都說墊腳凳模擬蹲姿比較好排便，要不要買一個？

◆ 一句話答案：腳凳不是必需品。有實證的姿勢重點是「身體前傾＋手撐膝蓋」，腳凳可以試，但別期待它是解答。



重點是「前傾 + 上肢有支撐」，雙腳踩實 → 肺活量與腹壓較大

(Tashiro et al., 2020；行動不便者可用床邊桌、輪椅桌板)

研究其實這麼說

- 健康年輕人的自我記錄研究：用腳凳「感覺」排得比較乾淨、比較不用力。
- 但針對便秘患者的隨機對照試驗發現：腳凳確實讓髖部角度變得更蹲姿，可是實際的排出時間、成功率、順暢感通通沒有改善。
- 真正有生理實證的是：身體前傾、上肢有支撐（手肘撐在膝蓋上，或前方放小桌板讓手撐著）——這個姿勢能產生較大的肺活量與腹壓，而腹壓才是排便的關鍵動力。

1 第一優先——姿勢：坐穩馬桶 → 身體前傾 → 手肘撐膝（或撐桌板）→ 雙腳踩實地面。

2 第二優先——時機：把握飯後 30 分鐘的「胃結腸反射」，尤其早餐後，固定去坐 5—10 分鐘。

3 基本盤：水喝夠（見 Q2）、纖維吃夠、白天多活動——便秘處理好，Q1 的頻尿常常也跟著改善。

4 腳凳？想試就試 2 週：主觀有改善就留著；沒感覺就收起來，不必勉強。衰弱長輩要注意腳凳可能增加起身時絆倒的風險。



分辨失智長輩是否便秘與促進排便技巧

YouTube 照護課程影片

<https://www.youtube.com/watch?v=9R7dZs1qYGQ>



五分鐘腹部運動，促進排便順暢

YouTube · 王柏堯 職能治療師（癌症希望基金會）

https://www.youtube.com/watch?v=r_imEubgz_w

實證來源：Tashiro et al. (2020), Journal of Physical Therapy Science（上肢支撐姿勢）；Modi et al. (2019), Journal of Clinical Gastroenterology（健康人自我報告）；Trieu et al. (2023), Neurogastroenterology & Motility（便秘患者腳凳 RCT）。

...

Q8

尿意一來就忍不住，有辦法「訓練」嗎？

情境：媽媽只要一有尿意就非衝廁所不可，出門都提心吊膽。她認知還不錯，想學方法。

◆ 一句話答案：有。認知功能還不錯的長輩，可以練「急尿煞車 5 步驟」+「膀胱再訓練」，研究顯示失禁次數可減少五到七成。



停下不動
別急著衝！



慢呼吸 2-3 次



快縮骨盆底肌
5-6 下



轉移注意力



從容走去廁所

急尿當下越急著衝，越容易漏——先「煞車」，讓尿意退潮再走。

膀胱再訓練（拉長間隔用）

1. 先記 3 天排尿日誌，看目前平均間隔多久（例如 1 小時）
2. 以此為起點，每 1—2 週把間隔延長 15—30 分鐘
3. 目標：3—4 小時上一次

骨盆底肌運動（基本功）

- 收縮 3—10 秒、放鬆同秒數，一回 10—15 下，一天 3 回
- 研究發現**每天做滿 30 下以上**的人效果最好——貴在持續，不在單次多用力

不處理會怎樣？同一系列研究的對照組（不做任何訓練），24 個月後漏尿量惡化了 184%。失禁不會自己好，但確實可以練回來。

影片參考



【骨盆底肌運動教學影片】熟練凱格爾，遠離尿失禁

YouTube · 高雄市政府衛生局

<https://www.youtube.com/watch?v=iOTgeDF6On0>



緊實骨盆底肌改善漏尿！物理治療師教你坐姿和站姿凱格爾運動（男女通用）

YouTube · 米蔚健康生活（物理治療師示範）

<https://www.youtube.com/watch?v=QivWR2TGFQY>

實證來源：McDowell et al. (1999) 與 Dougherty et al. (2002)，引自 Buck et al. (2024), Age and Ageing 系統性回顧。

• • •

Q9

什麼狀況應該趕快就醫？

情境：自己調整了一陣子，但不確定是不是該找醫師了。

◆ **一句話答案：**以下任何一項出現，請直接就醫，不要再自行觀察。

就醫紅旗清單

- ☐ 尿中帶血、排尿疼痛或灼熱
- ☐ 突然發燒 + 頻尿或尿失禁
- ☐ 失智長輩突然變得混亂、躁動、嗜睡（可能是感染的唯一表現）
- ☐ 完全尿不出來、或下腹脹痛
- ☐ 多尿 + 爆瘦 + 一直口渴（血糖警訊）
- ☐ 新發生的失禁合併下肢無力、麻木（神經警訊）
- ☐ 便秘超過一週、腹脹嘔吐

就醫時，如果能帶上「3 天如廁紀錄」，醫師的判斷會快很多：

時間	喝了什麼 / 多少	排尿或排便	有無漏 / 急	備註
06:30	溫水 200 ml	排尿	無	起床後
08:00	豆漿 250 ml	—	—	早餐
09:10	—	排尿	急、有漏一點	來不及脫褲
.....照這個格式記 3 天，就是給醫師最好的禮物。				

找誰？泌尿科（排尿問題）、高年科 / 神經內科（失智相關）、復健科與**職能治療師**（動線改造、輔具選用、如廁訓練——歡迎諮詢）。

這本手冊有幫上忙嗎？

我是施昱廷，職能治療師。

我持續在粉專分享失智照顧、如廁復能、高齡輔具的實證知識——
追蹤起來，下次遇到照顧難題，你會知道去哪裡找答案。

👉 追蹤「施昱廷 職能治療師」粉專

也歡迎把這本手冊分享給正在照顧路上的朋友 ❤️

本手冊為衛教資訊，不能取代醫療診斷與治療。長輩的個別狀況（如心衰竭、腎臟病之水分限制）請以醫師與醫療團隊的指示為準。手冊內容整理自公開發表之學術研究，引用出處如下；文中影片為外部公開資源，內容與著作權屬原創作者及其頻道所有，連結僅供延伸學習參考。

主要參考文獻 (APA 7)

- Buck, J., Fromings Hill, J., Collins, R., Booth, J., & Fleming, J. (2024). Effectiveness of non-pharmacological interventions delivered at home for urinary and faecal incontinence with homebound older people: Systematic review of randomised controlled trials. *Age and Ageing*, 53(6), afae126. <https://doi.org/10.1093/ageing/afae126>
- Hooton, T. M., Vecchio, M., Iroz, A., Tack, I., Dornic, Q., Seksek, I., & Lotan, Y. (2018). Effect of increased daily water intake in premenopausal women with recurrent urinary tract infections: A randomized clinical trial. *JAMA Internal Medicine*, 178(11), 1509–1515. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2018.4204>
- Jerez-Roig, J., Farrés-Godayol, P., Yildirim, M., et al. (2024). Prevalence of urinary incontinence and associated factors in nursing homes: A multicentre cross-sectional study. *BMC Geriatrics*, 24, 169. <https://doi.org/10.1186/s12877-024-04748-1>
- Kohno, K., Umemoto, N., Tsutsumi, R., et al. (2023). Diaper-zero program (prompted voiding care) improves diaper use in nursing home residents. *The Journal of Medical Investigation*, 70(1.2), 221–225. <https://doi.org/10.2152/jmi.70.221>
- Modi, R. M., Hinton, A., Pinkhas, D., et al. (2019). Implementation of a defecation posture modification device: Impact on bowel movement patterns in healthy subjects. *Journal of Clinical Gastroenterology*, 53(3), 216–219. <https://doi.org/10.1097/MCG.0000000000001143>
- Newman, D. K. (2019). Prompted voiding for individuals with urinary incontinence. *Journal of Gerontological Nursing*, 45(2), 14–26. <https://doi.org/10.3928/00989134-20190111-03>
- Tashiro, D., Nakahara, M., Kitajima, E., & Haraguchi, K. (2020). The effects of a defecation posture, supported by the upper limbs, on respiratory function. *Journal of Physical Therapy Science*, 32(5), 332–336. <https://doi.org/10.1589/jpts.32.332>

Trieu, R. Q., Prott, G., Sequeira, C., et al. (2023). Using a footstool does not aid simulated defecation in undifferentiated constipation: A randomized trial. *Neurogastroenterology & Motility*, 35(7), e14580. <https://doi.org/10.1111/nmo.14580>

© 2026 施昱廷 職能治療師 | 如廁訓練大寶典 (長輩如廁照顧 QA 手冊) v1.3

歡迎原樣分享；引用或改作請註明出處。